Eu apostei antes de olhar os números. Veja no que deu

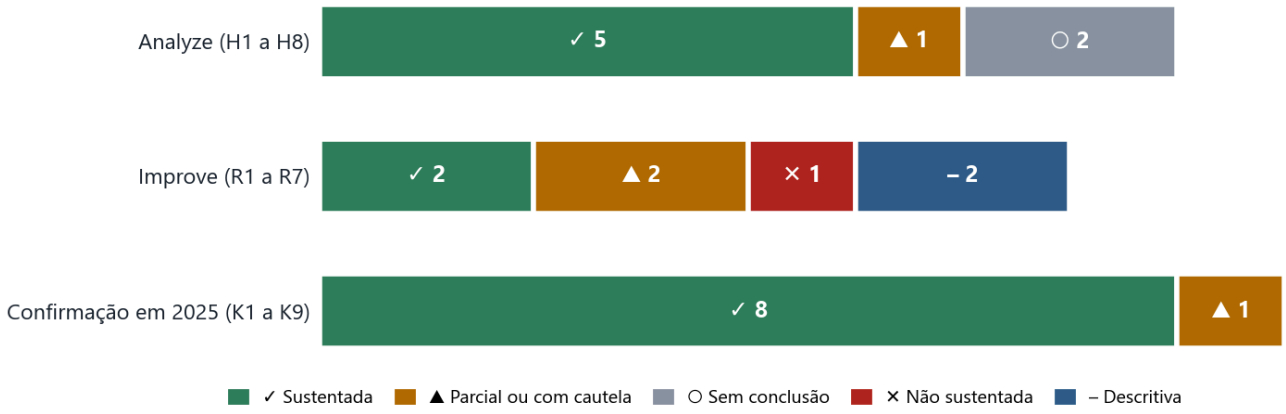
Documento 1 · Hipóteses e resultados — Saúde fiscal do Rio de Janeiro · Siconfi 2023 a 2025 · 25/10/2026

24 afirmações testadas ao longo do projeto, cada uma com a regra de decisão escrita antes de ver o resultado

Em poucas linhas. Antes de cada conta, eu escrevi o que esperava e o que faria cada resultado significar. Assim, ninguém (nem eu) pode ajustar a história depois. Das afirmações testadas, a maioria se confirmou, algumas ficaram sem conclusão e uma não se sustentou. Os números são declarados pelas prefeituras e pelo estado, e não foram auditados. Gasto em saúde não mede a qualidade do atendimento.

1 Por que escrever a aposta antes

Quem analisa dados pode, sem querer, procurar até achar algo que pareça certo. Para evitar isso, cada pergunta tem um **critério de decisão escrito com data antes da conta**: o que eu espero e o que vou chamar de "confirmado", "parcial" ou "não sustentado". **"Sem conclusão" é um resultado válido**: quer dizer que os dados não permitem decidir, e não que não há diferença.



2 Etapa Analyze: o que explica o gasto?

A pergunta central: **o gasto baixo da Região Metropolitana em saúde por habitante se explica pela receita por habitante?**

ID	A AFIRMAÇÃO, EM PALAVRAS SIMPLES	O QUE DEU	RESULTADO
H1	Com a mesma receita por habitante, a Metropolitana (sem a capital) não gasta diferente	Diferença de −4,4%, mas o intervalo vai de −18% a +12%	Sem conclusão
H2	A Baixada (6 cidades) gasta menos do que a receita prevê	−3,5%, com intervalo de −18% a +14%	Sem conclusão
H3	A capital gasta menos porque dedica fatia menor da receita à saúde	35% a 37% abaixo do previsto; fatia de 19,6% contra mediana de 29,2%	Sustentada
H4	O padrão de 2024 se repete em 2023	Elasticidade 0,80; capital abaixo do previsto	Confirmada
H5	Como se comportam as cidades de maior receita?	Quanto maior a receita, menor a fatia para a saúde (elasticidade 0,81)	Respondida
H6	O gasto acompanha mais os repasses que a arrecadação própria	Repasses 0,68 contra 0,12 da receita própria	Confirmada
H7	Casas de veraneio inflam a receita por habitante	Resíduo das Baixadas Litorâneas de −15% para −9%	Parcial
H8	Todas cumprem o mínimo de 15% da saúde	92 de 92; mediana de 23,3%	Confirmada

ACHADO

A receita explica cerca de 80% da variação do gasto. Quando se compara cidades com a mesma receita por habitante, a diferença da Metropolitana cai de 16% para 4%. O gasto segue os repasses (como os do SUS) muito mais que a arrecadação própria.

CUIDADO

Uma expectativa que o dado contrariou. A expectativa inicial era que mais receita levasse a uma fatia maior para a saúde. Aconteceu o contrário: a fatia cai quando a receita sobe.

3 Etapa Improve: o que fazer com isso?

ID	A FERRAMENTA PROPOSTA	O QUE DEU	RESULTADO
R1	Triagem: listar cidades que gastam bem abaixo do que a receita prevê	4 cidades sinalizadas; 2 das 3 do ano anterior se repetem	Sustentada
R2	Comparar cada cidade com outras de receita parecida	A dispersão cai 46% (esperado: ao menos 20%)	Sustentada
R3	Corrigir a população das cidades de veraneio	Somar visitantes **piorou** o resíduo, de −15% para −18%	Não sustentada
R4	Teste de estresse: e se os repasses caírem?	Entre cidades 0,68; dentro da cidade 0,28	Com cautela

ID	A FERRAMENTA PROPOSTA	O QUE DEU	RESULTADO
R5	Folga sobre o mínimo de 15%	18 cidades com folga menor que 3 pontos	Descritiva
R6	Comparar o SIOPS com o Siconfi	11 cidades fora da faixa; serve como pergunta	Com cautela
R7	Painel de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal	22 municípios declaram pessoal acima do limite prudencial	Descritiva

FALHA

Três apostas minhas erraram: eu esperava as Baixadas Litorâneas bem representadas na triagem, no máximo 6 cidades com pouca folga e no máximo 10 com pessoal acima do limite. Os números reais foram 1 de 10, 18 e 22. Isso está registrado como resultado.

4 Etapa Control: o que resiste a um ano novo?

Abri os dados de 2025 **uma única vez**, depois de escrever as previsões. Das nove conclusões testadas, **oito se mantiveram**, uma enfraqueceu e nenhuma caiu.

ID	CONCLUSÃO QUE VEIO DE ANTES	EM 2025	RESULTADO
K1	A receita tem elasticidade abaixo de 1	0,74 (0,63 a 0,86)	Sustenta
K2	A Metropolitana segue sem conclusão	−7,2% (−21% a +9%)	Sustenta
K3	A capital fica abaixo do previsto	−33,5%	Sustenta
K4	O gasto segue os repasses	0,67 contra 0,11	Sustenta
K5	A lista da triagem se repete	Só 1 das 3 cidades repete	Enfraquece
K6	Comparar por receita parecida lê melhor	Dispersão cai 46%	Sustenta
K7	Repasses movem o gasto dentro da cidade	0,59 (0,27 a 0,92)	Sustenta
K8	Baixadas Litorâneas seguem abaixo do previsto	−15,6%	Sustenta
K9	Somar visitantes continua piorando o resíduo	Piora nos 3 cenários	Sustenta

A triagem é estável como ordem, mas não como lista. A ordem das cidades se mantém (correlação +0,83), mas só Niterói fica fora do intervalo nos três anos (−49%, −48% e −44%). Isso mostra que a ferramenta serve para perguntar, e não para fazer lista fixa.

5 O que este documento não diz

- **Não diz que alguma cidade está errada.** Uma cidade sinalizada é uma cidade para olhar.
- **Não mede qualidade da saúde.** Mede gasto declarado.

- **Os dois anos usam as mesmas cidades.** Confirmar em 2025 mostra estabilidade no tempo, e não vale para outros lugares.
- **Fora do núcleo:** os dados do IBGE (idade e saneamento) e do SUS (leitos) foram tratados como extensões, e ficam para depois.

Para saber mais

Relatórios completos de cada fase, hipóteses com data e scripts: github.com/MatheusAugustoEC/saude-rj.